

口から食べられなくなった方とご家族へ

飲み込む力（嚥下機能）を内視鏡で評価しました。認知症や誤嚥のために、口から食事を取れません。嚥下のリハビリ訓練をしても回復しませんでした。

年 月 日 嚥下ケアチーム回診での評価と判断

今後どうしたら良いか、次の医療処置から選んでください。

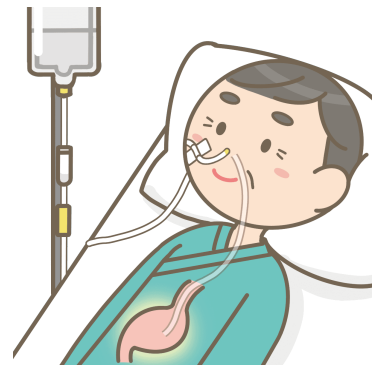
1. 点滴を続ける

点滴するには、入院を続けます。胃腸を使わず、栄養は不足気味です。どれだけ生きるかは、その人によりますが、病院で看取ることになります。手足からの点滴の場合、血管が漏れたら、そのつど針を刺します。血管が見つからないこともあります。太い静脈から栄養点滴することもあります。主治医の判断で決めます。認知症があると管を抜いてしまうので、手足をしぼること（身体抑制）もあります。



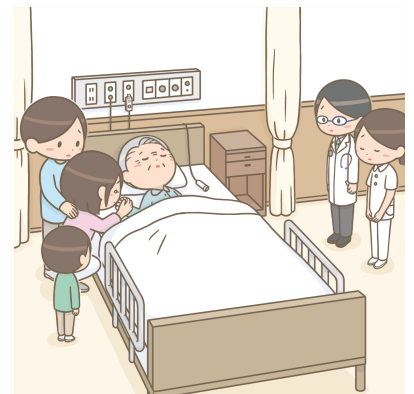
2. 胃管を入れる

鼻から胃まで長い管をいれて、流動食を流し込みます。老人施設でも対応できます。栄養は十分入ります。鼻に管が入るので、違和感があります。認知症があると管を抜いてしまうので、手足をしぼること（身体抑制）もあります。



3. お口のケアだけして、何も食べない

本人の希望を聞いて、湿らす程度の水や氷は口に入れます。病院でも、老人施設でも、ご自宅でも過ごせます。人間の自然な経過に任せます。多くは眠る時間が増えて静かに過ごしますが、急変することもあります。尊厳死と延命治療しない同意書にもサインをお願いします。



どの処置を選んだ場合でも、状態によっては医師の判断で、投薬のために点滴をすることがあります。お口のケアや嚥下のリハビリも、可能な限り続けます。

同意書

経口摂取困難での医療処置について

病院長殿

上記の説明を理解し、本人の意思を尊重し、家族でも相談して、以下の方法を選択します。

1. 点滴を続ける
2. 胃管を入れる
3. 何も食べない

今はまだ決められない時は、複数の処置を選択してください。状態によって、主治医が判断して対応します。また、この選択はいつでも変更できますので、申し出てください。

年 月 日

説明した医師

立ち会い看護師

患者氏名（代筆・自署）

家族代表者

同意書

尊厳死と延命治療しない意思表示について

病院長殿

食事も取れず、回復は難しい病状を理解しました。苦しみを取るため、最低限の医療行為のみ受けます。強い痛みを伴う必要のない処置は望みません。近いうちに亡くなることも分かります（尊厳死）。延命のための医療行為（人工呼吸、心臓マッサージ等）は希望しません。本人が意思表示できない状態でも、家族で相談の上、本人だったらこうすると意見が一致しました。

年 月 日

説明した医師

立ち会い看護師

患者氏名（代筆・自署）

家族代表者
